

Ihr autistischer junger Erwachsener / Ihre autistische junge Erwachsene im Studium

Für Eltern und Familie — einen autistischen Studierenden (etwa 18–25 Jahre) unterstützen.

Die Kernidee

Autismus bedeutet über den **Monotropismus**, dass sich die Aufmerksamkeit Ihres jungen Erwachsenen in wenige tiefe, intensive „Tunnel“ einschließt. Das Studium ist ein *gewaltiger* Übergang: neue Autonomie, weniger Struktur, überall Großraum, Gruppenarbeit und sozialer Druck. Viele autistische Studierende blühten unter der Vorhersagbarkeit der Schule auf und **prallen dann an eine Wand** — Burnout, Angst oder Krise im ersten oder zweiten Jahr. Ihre fokussierten Interessen sind eine echte Stärke; das System um sie herum ist meist das Problem. Ihre Rolle ist **Autonomie zu unterstützen, nicht zu managen** — glauben Sie ihnen, helfen Sie beim Praktischen und stützen Sie die Anpassungen.

Was Sie beobachten könnten — und was wirklich dahintersteckt

Sie könnten sehen...	Was oft tatsächlich passiert
War „gut“, kann nun nicht teilnehmen, essen oder funktionieren	Autistisches Burnout durch eine vielspurige, unvorhersehbare Umwelt
Antwortet nicht, zieht sich zurück, wird still	Shutdown/Erholung unter Überlastung — kein „Ghosting“
Erst jetzt, in der Krise, diagnostiziert	Das Studium ist ein häufiger Punkt später Erkennung („verlorene Generation“)
Bevorzugt Text gegenüber Anrufen; meidet Gruppen-Settings	Eingekanalige Kommunikation; Schreiben senkt die Last
Überspringt Vorlesungen, verpasst Fristen	Autistische Trägheit + exekutive Last unter chronischer Erschöpfung

Versuchen Sie dies

- **Glauben Sie ihr** — wenn sie Ihnen sagt, sie sei autistisch, kämpfe oder brenne aus, ist das Beste, was Familie tun kann, zuzuhören und zu lesen, was sie teilt.
- **Helfen Sie beim Praktischen**, wenn darum gebeten: Anmeldung beim Behindertenservice, Anpassungen, Termine, Finanzen — diese Systeme allein zu bewältigen ist erschöpfend.
- **Normalisieren Sie reduzierte Last**. Eine vorübergehende Reduktion der Studienlast oder ein Studienunterbruch ist ein legitimer, evidenzangemessener Erholungsschritt — kein Scheitern.
- **Kommunizieren Sie schriftlich, auf ihre Bedingungen**, und achten Sie ihre Autonomie; bieten Sie an, drängen Sie nicht auf.
- **Schützen Sie ihre Interessen und Ruhepausen** als Wohlbefindens-Ressourcen, nicht als Faulheit.

Vermeiden Sie dies

- Eine späte Erkennung abtun („aber du bist doch so normal!“) — Zurückweisung durch die Familie kann mehr verletzen als die Jahre des Nicht-

Wissens.

- „Zieh es durch“ oder allgemeinen Sozialrat drängen, der Masking erhöht.
- Für sie entscheiden — bevorzugen Sie unterstützte Entscheidungsfindung.

Wann weitere Hilfe nötig ist

Achten Sie auf **autistisches Burnout** (Erschöpfung, Kompetenzverlust, verminderte Reiztoleranz) und **Suizidalität** — fragen Sie direkt. Verweisen Sie an den **universitären Behindertenservice**, Mentoring und autistische Studierenden-Communities. Behandeln Sie begleitende **ADHD, Angst, Schlaf- und GI-Zustände** mit autismus-informierten Kliniker:innen.

Wenn Ihr/e junge/r Erwachsene eine Frau ist

Frauen und Studierende marginalisierter Geschlechter sind unter den spät-erkannten überrepräsentiert und masken stark. Ein „leistungsstarkes, oberflächlich geselliges“ Erscheinungsbild mit privatem Zusammenbruch ist ein Schlüsselmuster — nehmen Sie die Lücke zwischen öffentlicher Leistung und privater Erschöpfung ernst.

Über diesen Leitfaden

KI-gestützt, abgeleitet aus den Forschungsentwürfen dieses Projekts — der Leitfaden für die **Familie** (Teil 4) und das **Monotropismus**-Dossier; mit dem Leitfaden für **Praktiker und Gesundheitsfachleute über die Lebensspanne** (Teil 3.4). Verwendet identitätsfirst-Sprache. **Information — kein medizinischer Rat und kein diagnostisches Werkzeug.** Passen Sie es an die einzelne Person an.

Schlüsselquellen. Murray, Lesser & Lawson (2005); Murray, F. (2023); Dwyer (2025); Raymaker et al. (2020); Pearson & Rose (2021); Knight (2021). Vollständige Nachweise finden sich in den Quelldossiers.